

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Tomás Ignacio Restrepo Vargas

DOCUMENTO

TI 1121000099

FECHA NACIMIENTO

18/04/2013

EDAD

13 años, 8 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

4° Primaria

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

14/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

bateria_completa_infantil

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Tomás Ignacio Restrepo Vargas	Lateralidad:	Diestro
Documento:	TI 1121000099	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	18/04/2013	Ciudad:	Pereira
Edad:	13 años, 8 meses	Acompañante:	Madre Lucía Vargas
Sexo:	Masculino	Remite:	Colegio + familia
Escolaridad:	4° Primaria	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Madre y colegio reportan dificultades severas en matemáticas desde 1° grado. Lectura y escritura en rango normal-bajo. Conducta desatenta en clase. Evaluado previamente (WISC-IV en 2024) con perfil irregular. Solicita actualización completa.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: bateria_completa_infantil

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Números y Letras	Memoria de Trabajo	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Aritmética	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
PAS Total	Socioemocional - Ansiedad	—
CDI Escala de depresión	Socioemocional - Depresión	—
Interacción Social	Socioemocional - TEA	—
Patrones Restringidos de Conducta	Socioemocional - TEA	—
Patrones Cognitivos	Socioemocional - TEA	—
Habilidades Pragmáticas	Socioemocional - TEA	—
Coefficiente de Trastorno de Asperger	Socioemocional - TEA	—
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Tomás obtuvo un CIT de 50 (extremadamente bajo), con un perfil homogéneo entre los índices compuestos.

Hallazgos clave

- Velocidad de Proceso severamente descendido ($Z \approx -3.0\sigma$)
- Atención preservado ($Z \approx +4.0\sigma$)

Implicación

El perfil sugiere necesidad de apoyos específicos en las áreas más descendidas; se recomienda intervención focalizada.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención sostenida снижена. Span atencional de 4-5 minutos. Errores por descuido en tareas de cálculo. Necesita re-dirección externa frecuente.

Memoria

Memoria de trabajo auditiva dentro de lo esperado. Memoria visual снижена percentil 25-50. Curva de aprendizaje verbal plana (3 palabras en 3 ensayos).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje comprensivo y expresivo en percentil 50-75. Vocabulario en percentil 90. Comprensión de instrucciones complejas preservada.

Funciones ejecutivas

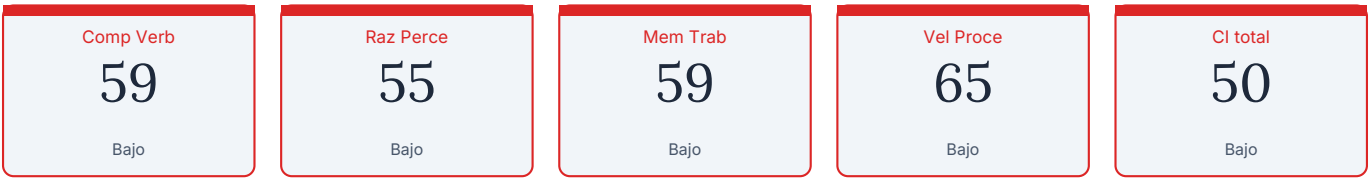
Funciones ejecutivas heterogéneas. Planeación preservada. Flexibilidad снижена (categorías WCST 4/6). Inhibición en percentil 25. Velocidad de procesamiento снижена percentil 16.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F81.2 - Trastorno del cálculo + comorbilidad atencional

RESULTADOS CUANTITATIVOS

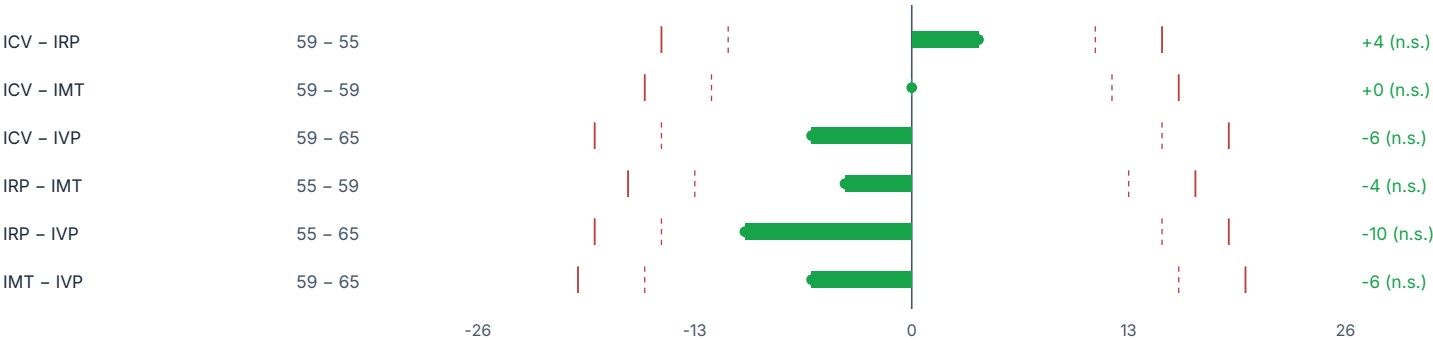
Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente



Discrepancias entre índices

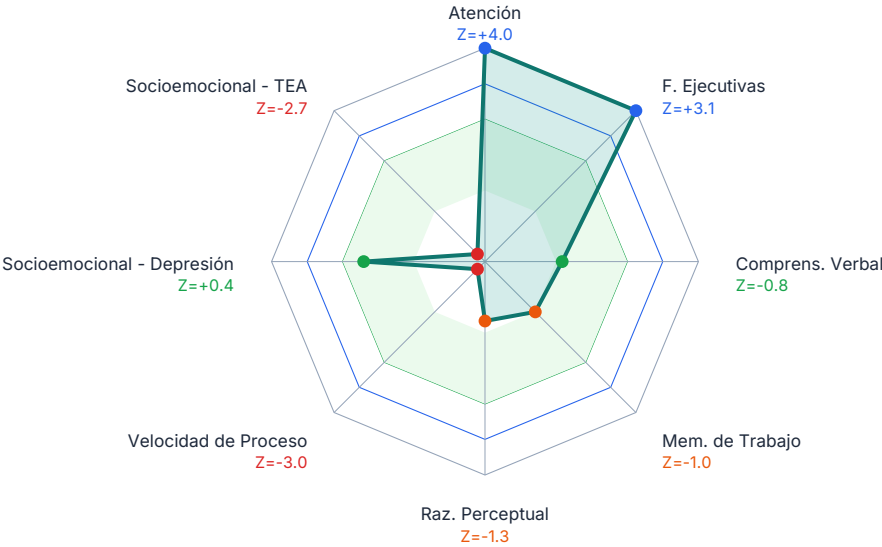
Líneas punteadas: tendencia ($p < .25$). Líneas continuas: diferencia confiable ($p < .05$). La barra central es la diferencia observada entre los dos índices.

Diferencia = valor del primer índice – segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p < .15$ y $p < .05$).



Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

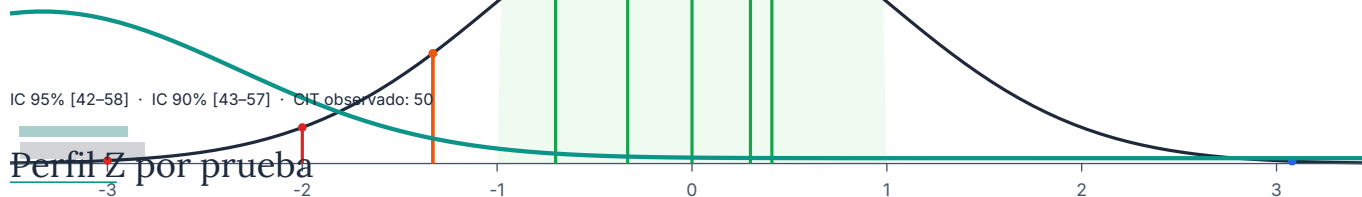


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 14 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							-1.33
Semejanzas							-0.33
Vocabulario							-1.33
Números y Letras							+0.00
Claves							-3.00
Aritmética							-2.00
Ind Comp Verb							-2.73
Ind Raz Perce							-3.00
Ind Mem Trab							-2.73
Ind Vel Proce							-2.33
CI total							-3.33
CDI Escala de depresión							+0.41
Interacción Social							+0.30
Patrones Restringidos de Conducta							-4.10
Patrones Cognitivos							-4.60
Habilidades Pragmáticas							-4.50
Coefficiente de Trastorno de Asperger							-0.70
TMT A							+4.00
TMT B							+3.08

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z ⁺	BANDA
● Velocidad de Proceso	-3.00 σ	severo
● Socioemocional - TEA	-2.72 σ	severo
● Razonamiento Perceptual	-1.33 σ	moderado
● Memoria de Trabajo	-1.00 σ	moderado
● Comprensión Verbal	-0.83 σ	promedio
● Socioemocional - Depresión	+0.41 σ	promedio
● Funciones Ejecutivas	+3.08 σ	superior
● Atención	+4.00 σ	superior

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	28	6	-1.33	Límitrofe
Semejanzas	24	9	-0.33	Promedio
Vocabulario	30	6	-1.33	Límitrofe
Números y Letras	18	10	+0.00	Promedio
Claves	26	1	-3.00	Bajo
Aritmética	14	4	-2.00	Bajo
Ind Comp Verb	9	59	-2.73	Bajo
Ind Raz Perce	8	55	-3.00	Bajo
Ind Mem Trab	6	59	-2.73	Bajo
Ind Vel Proce	7	65	-2.33	Bajo
CI total	30	50	-3.33	Bajo
PAS Total	60	—	—	Sin dato
CDI Escala de depresión	14	0	+0.41	Promedio
Interacción Social	12	53	+0.30	Promedio
Patrones Restringidos de Conducta	14	9	-4.10	Bajo
Patrones Cognitivos	6	4	-4.60	Bajo
Habilidades Pragmáticas	8	5	-4.50	Bajo
Coefficiente de Trastorno de Asperger	6	43	-0.70	Promedio
TMT A	50	4	+4.00	Superior
TMT B	90	3	+3.08	Superior

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Tomás obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 50, ubicándose en la categoría extremadamente bajo (percentil aproximado 0). Los índices compuestos muestran homogeneidad relativa (rango IRP=55 a IVP=65), lo que respalda la interpretación del CIT como medida representativa.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-3.0$); socioemocional - tea (severamente disminuido, $Z=-2.7$); razonamiento perceptual (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$). Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: atención (muy alto, $Z=+4.0$); funciones ejecutivas (muy alto, $Z=+3.1$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Patrones Cognitivos ($Z=-4.60$, bajo); Habilidades Pragmáticas ($Z=-4.50$, bajo); Patrones Restringidos de Conducta ($Z=-4.10$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Patrones Cognitivos — bajo ($Z=-4.60$)
- Habilidades Pragmáticas — bajo ($Z=-4.50$)
- Patrones Restringidos de Conducta — bajo ($Z=-4.10$)
- Claves — bajo ($Z=-3.00$)
- Aritmética — bajo ($Z=-2.00$)
- Diseño con Cubos — límite ($Z=-1.33$)

Áreas con desempeño preservado / superior

- TMT A — superior ($Z=+4.00$)
- TMT B — superior ($Z=+3.08$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Tomás. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Números y Letras, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En CDI Escala de depresión, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Diseño con Cubos, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Velocidad de Proceso · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Socioemocional - TEA · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Razonamiento Perceptual · moderado

- Armar rompecabezas, mapas o instrucciones de muebles.
- Entender relaciones espaciales (izquierda-derecha, arriba-abajo, rotar mentalmente).
- Resolver problemas lógicos nuevos.

Apoyos sugeridos: Practicar con rompecabezas, tangram, cubos de Kohs, videojuegos de lógica. · Usar material concreto (cubos, figuras) para aprender conceptos abstractos.

Memoria de Trabajo · moderado

- Hacer una operación mental mientras se recuerda otra cosa (ej. contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7).
- Anotar un teléfono mientras se escucha otra indicación.
- Seguir una receta de cocina o instrucciones de varios pasos.

Apoyos sugeridos: Repetir en voz alta lo que se acaba de escuchar. · Anotar inmediatamente la información importante.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Números y Letras, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En CDI Escala de depresión, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Interacción Social, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Coeficiente de Trastorno de Asperger, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En Diseño con Cubos, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Aritmética, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Ind Comp Verb, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: ADAPTACIONES CURRICULARES: tiempo extendido en evaluaciones (1.5x), calculadora autorisée, problemas contextualizados en lugar de abstractos, evitar dictado de números. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). En el colegio/academia: puede ser útil hablar con tus profesores para explorar apoyos como tiempo extra en exámenes o actividades adaptadas. Recomendación: Psicoeducación a docentes sobre discalculia y comorbilidad atencional. Evitar etiquetas de 'flojo' o 'poco inteligente'. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Apoyo parental en tareas: priorizar comprensión sobre velocidad, evitar castigo por errores en aritmética, celebrar logros en otras áreas. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

¿Qué hago con las áreas donde me fue muy bien?

¡Celebra y potencia esas fortalezas! Pueden ser tu ancla para compensar las áreas que requieren más esfuerzo. Compartir esto con tu familia, colegio o terapeuta les permite diseñar estrategias que aprovechen lo que mejor te sale.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F81

Impresión diagnóstica: F81.2 - Trastorno del cálculo + comorbilidad atencional

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

Escolar

- ADAPTACIONES CURRICULARES: tiempo extendido en evaluaciones (1.5x), calculadora autorisée, problemas contextualizados en lugar de abstractos, evitar dictado de números.
- Refuerzo escolar en matemáticas con metodología multisensorial (CRA, método Singapur adaptado, materiales concretos). Mínimo 3 horas/semana durante próximo año lectivo.
- Psicoeducación a docentes sobre discalculia y comorbilidad atencional. Evitar etiquetas de 'flojo' o 'poco inteligente'.

Familiar

- Apoyo parental en tareas: priorizar comprensión sobre velocidad, evitar castigo por errores en aritmética, celebrar logros en otras áreas.
- Coordinación con colegio para seguimiento mensual. Reevaluación neuropsicológica en 18 meses para monitorear progreso.

Terapéutica

- Programa de estimulación de habilidades numéricas básicas (subitización, conteo, composición numérica) — 16 sesiones con frecuencia semanal.
- Evaluación y posible intervención TDAH comórbido (SNAP-IV pendiente aplicación completa).